



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رابعياً : ميرفت منازع قاسم منازع
المحافظة : المنيا الحي / المدينة : مركز المنيا
رقم البطاقة : 27108112400106 رقم التليفون : 01117895109
العنوان : الجديد
العمر (تاريخ الميلاد) : 11-08-1971 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : _____ التوقيع : _____
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : _____ التوقيع : _____
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : _____ التوقيع : _____
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : _____
خطة العلاج : _____
المستشفى : _____ قسم : _____
جهة العلاج : _____ نفقات : _____
ملاحظات : _____

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ميرفت منازع قاسم منازع National ID: 27108112400106	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



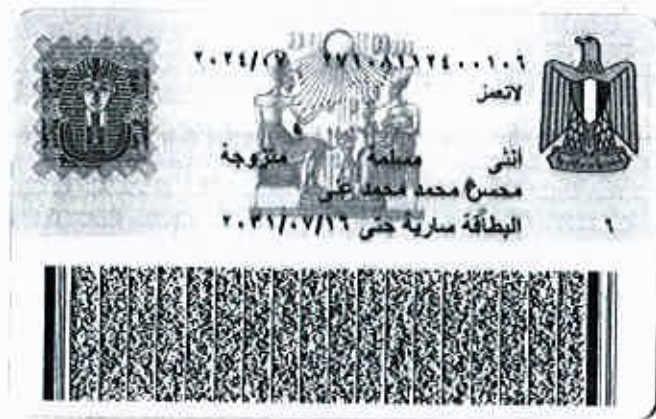
معرفة
مفازع قاسم مفازع
عين شمس - تقسيم شادي الجديد
شأن العتيا - العتيا

٢٧١٠٨١١٢٤٠٠١٠٦

KQ5431865



Name: MR. :	ميرفت منازع قاسم 1289	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
DEXA SCAN 11/2025: SPIN OSTEOPOROSIS CXR 11/2025: INCREASE VASCULAR MARKINGS MRI BRAIN 11/2025: FREE BIOPSY FROM LT AXILLARY LYMPHNODE: REACTIVE LUMPHOID NO MALIGNANCY CT CAP --> tiny pul nodules 4 mm for FU MRI spine --> C5, 6 disk and L2,3 disk for continue on AI ARAMIDEX + SUPP >> 3M NEXT VISIT AFTER 3 MO CT CAP >> R ARAMIDEX + SUPP >> 3M NEXT VISIT AFTER 3 MO CT CAP >> R CLINIC AFTER CT CAP REPORT CT CAP 6-2023 --> regression of pul tiny nodules 4 mm vs 1.5 mm newly develop pulmonary nodules 1 mm rt axillary LN 1.1 cm for new breast US مش عارف ازارى دتور الاشعه شفها ??? C/o...bilateral LL oedema O/e...bilateral below knee mild pitting oedema Discrepant CT results...mammosonography revealed BIRADs II results. For...labs & CT CAP follow-up after 3 mths. Meanwhile, keep on Arimidex. Next visit after 1 month.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ :
	mohamed ismael	20-09-2026
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		



MDT form

APPROVED TO

1- Name: **د. محمد بن عبد الله بن محمد**

Sex:

3- Medical numbers

Female

09216748

01/10/2023

11/10/2023

2- ID number

Patient Age: 54 Y

Family history

None

Phone

01117575109

Site

REASON OF INT

Marital status

Married

NRS Score

1-5/5

GROUP

Date of: DT

Comorbidity

Diabetes

Menopausal status

Postmenopausal

Initial STAGE

IIA

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

CT C/P + LT breast mass & pathologically LN
no hepatic focal deposits

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

RIB7

IDC

8/8

6/8

3

T

N

M

2

1

0

Sonomammography

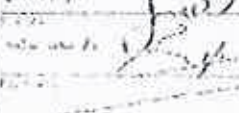
LY retro areolar nipple infiltrating mass WITH ipsilateral level 1 (BIRADS)

PATIENT HISTORY

pt received 18 wks of NACT (TCHP) with good clinical response
post CBS+ALND: IDC tumor cellularity 15% DCIS--> focal 5% LR 1/19
free all resected margins partial pathological response
then ended adj kadcycla (TDH1) on 16/9/2024
on AI since 12/2023 till now
1/2025 BSM: few ill xillary pathological LN
O/E: cl4d IDC
she refused new BX

MDT OUTCOME & PLAN

We convinced her to go for US guided biopsy from the suspected recurrence.
If +ve, For mastectomy

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Patient Name :
Patient No : 27108112400108
Path No. : 616/25
Sex : Female
Age : 53 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001654
Request Date : 12/02/2025
Verification Date : 27/02/2025
Financial Category : Out Patient
Department :
Registered by : manwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data

Enlarged left axillary tail lymph node, status post right CBS

Nature of specimen

Trucut biopsy collected at 11/2/2025, at 10:45 am

Gross examination

Multiple grey white tissue cores from 0.3 cm up to 1 cm, totally submitted

Histopathology

Microscopic examination revealed cores of nodal tissue with preserved architecture and marked paracortical expansion with irregular nodular pale areas located adjacent to the subcapsular sinuses and capsule. High power shows the pale areas composed of interdigitating dendritic cells and Langerhans cells admixed with small lymphocytes, plasma cells, eosinophils and histiocytes. The histiocytes contain melanin pigment.

Diagnosis

Left Enlarged axillary lymph node, trucut biopsy, Dermatopathic lymphadenopathy

Signature
Dr. Walaa Ghoeneim
Dr. Heba Hassan

Verified by
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 27/02/2025 14:40:26

Page 1 of 2

Printing By : Dr. Taka Elgaray

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987, Nile Corniche - Mistr El Qadima - Cairo, Egypt

MRN: 10123222064
Patient Name: MERVAT MONAZA KASFILIONAZA

D.O.B: 11/08/1971
IC No.: 27108112100106
SEX: Female
Location: External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY

Hormone receptors

Specimen Id 2303220406
Accession No IMM23-2111
Sample Type Paraffin Block

Collection Date 22/03/2023 04:27 PM
Received Date 22/03/2023 04:23 PM
Doctor Mohamed Ataf Ashour MD, PhD

History, Relevant Clinical Findings & Previous Inv.
Results:

Reason for Order:

Immunohistochemical Report

pathology number

2609-23.

Clinical Data

LL breast cancer.

Gross Picture:

Referred block submitted for ER/PR immunostaining.

System Used:

Ventana BenchMark ULTRA autostainer

Antibody:

Ventana anti-PR(1E2) Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER(SP1) Rabbit monoclonal antibody.

Scoring system:

According to the ASCO/CAP guideline update, 2019: Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive.

Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Comment:

- There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expressers (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and their potential benefit from endocrine therapy.

- PR positive in 1-20% of tumor cells is considered as Low positive.

(Laterality) breast Cancer:

left

Diagnosis:

ER: Positive, strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (8/8).

PR: Positive, intermediate nuclear reaction in 50% of tumor cells (5/8).

Signature

Heba Abdallah

Patient Name: Mervat Monazaa Kasem Monazaa	Date : 05/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1335/2023	42552

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST:

I. Chest:

****Compared to the last study on 23/10/2023:**

- Progressive size of the left breast retro-areolar ill-defined soft tissue lesion seen inseparable from the skin with diffuse left breast skin thickening.
- Few reticulations noted on lingula likely post-radiation sequel.
- No sizable pulmonary nodules, masses or consolidations.
- Few subcentimetric mediastinal lymph nodes.
- Few prominent axillary lymph nodes noted.
- No evidence of pleural effusion, thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal appearance of the chest wall.

II. Abdomen and pelvis:

- The liver of average size with homogenous CT texture. No evidence of definite focal lesions on non-contrast base.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

III. The scanned skeleton:

- No worrisome lytic or sclerotic osseous lesions.

Patient Name: Mervat Monazaa Kasem Monazaa	Date : 05/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1335/2023	42552

OPINION:

- Progressive size of the left breast retro-areolar soft tissue lesion for further evaluation by mammography.
- No evidence of pulmonary, hepatic or osseous definite metastatic deposits on non-contrast base.

Dr. Sherif Sameli, M.D.

Patient Name: Mervat Monazaa Kasem Monazaa	Date : 06/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1335/2023	Pat. ID 42552

BILATERAL BREAST HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral breast ultrasound

Report:

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable masses
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- Small retroareolar collection measuring 18 X 20 mm.
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- No solid masses
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary L.N.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2).
- Normal study of the right breast (BIRADS 1).

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.